

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076534-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: NALVA HELENA CORDEIRO LIRA GUILHERME

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO ONCOLOGISTA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5076534-85.2024.4.02.5101

510014937985 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076534-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: NALVA HELENA CORDEIRO LIRA GUILHERME

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual **NALVA HELENA CORDEIRO LIRA GUILHERME** objetiva reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência no processo originário por meio da qual foi postulada a realização de “CONSULTA EM ONCOLOGIA com respectivo atendimento integral em razão de diagnóstico de neoplasia”

O parecer do NAT foi juntado no Evento 12.

A tutela de urgência foi concedida no Evento 18.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência (Evento 19), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão, verbis:

“A autora requer a concessão da tutela provisória de urgência, os réus providenciem a necessária CONSULTA EM ONCOLOGIA, em até 72 horas, como também o imediato tratamento oncológico necessário.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Ainda, diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for do seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Venham conclusos para sentença de mérito ou terminativa, não havendo proposta de acordo¹.

Afirmou a parte autora que foi diagnosticada com adenocarcinoma de sigmoide em 20/05/2024, que foi submetida a procedimento cirúrgico de retossigmoidectomia de Hartmann em abril de 2024 e que no momento está aguardando seguimento do tratamento junto à oncologia clínica. Alegou que a o início do tratamento oncológico não foi respeitado, uma vez que já possui diagnóstico de câncer desde 20/05/2024, mas ainda não conseguiu acesso à sua primeira consulta oncológica e não há sequer agendamento.

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora comprovou os requisitos.

A parte autora comprovou ter diagnóstico de adenocarcinoma de cólon sigmoide (Evento 1, ANEXO2, Páginas 15 e 16).

O NAT juntou parecer no evento evento 12, PARECER1.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

Processo nº 5076534-85.2024.4.02.5101,
ajuizado por **Naiva Helena Cordeiro**
Lira Guilherme.

Trata-se de Autora, 49 anos de idade, com diagnóstico de **adenocarcinoma de cólon sigmoide** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 15 e 16), solicitando o fornecimento de **consulta em oncologia e tratamento oncológico** (Evento 1, INIC1, Página 7).

De acordo com as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Cólon e Reto, aprovadas pela Portaria nº 958, de 26 de setembro de 2014¹, o tratamento padrão para o câncer do reto é a ressecção cirúrgica do tumor primário. A quimioterapia adjuvante está indicada para doentes com câncer colorretal no estágio III e, excepcionalmente, no estágio II, a critério médico. A quimioterapia prévia (pré-operatória) está indicada para doentes com câncer de reto no estágio II ou III, associada à radioterapia. A decisão quanto à indicação da radioterapia adjuvante para doentes com câncer de reto no estágio I deve considerar a extensão da neoplasia e o grau de diferenciação histológica do tumor. Doentes com diagnóstico de câncer colorretal devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.

Diante do exposto, informa-se que **consulta em oncologia e tratamento oncológico estão indicados** ao manejo da condição clínica da Autora - **adenocarcinoma de cólon sigmoide** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 15 e 16). Além disso, **estão cobertos pelo SUS**, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual constam: consulta médica em atenção especializada, tratamento clínico de paciente oncológico, tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades oncológicas, sob os seguintes códigos de procedimento: 03.01.01.007-2, 03.04.10.002-1, 03.03.13.006-7, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

No que tange ao acesso no SUS, a Atenção Oncológica foi reestruturada em consonância com a Rede de Atenção à Saúde e de forma articulada entre os três níveis de gestão (atenção primária, atenção secundária e atenção terciária).

O Componente de Atenção Especializada é composto por ambulatorios de especialidades, hospitais gerais e hospitais especializados habilitados para a assistência oncológica. Esses devem apoiar e complementar os serviços da atenção básica na investigação diagnóstica, no tratamento do câncer (...), garantindo-se, dessa forma, a integralidade do cuidado no âmbito da rede de atenção à saúde. O componente da Atenção Especializada é constituído pela Atenção Ambulatorial e Hospitalar.

A Atenção Hospitalar é composta por hospitais habilitados como UNACON (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e CACON (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e por Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, nos quais

O parecer esclareceu que a consulta em oncologia e tratamento oncológico estão indicados ao manejo da condição clínica da Autora.

Afirmou que " Consulta - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), solicitada em 05/09/2024, pelo Cento Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello, diagnóstico: Neoplasia maligna do colón, classificação de risco: Verde: prioridade 3, situação: Em fila, posição: 439".

Assim, enquanto a parte autora aguarda o devido tratamento para a sua enfermidade, o tempo decorrido acarreta agravamento do quadro clínico e aumento da possibilidade de evolução para óbito.

Presentes, portanto, o periculum in mora e o fumus boni juris.

Quanto à argumentação sobre a necessidade de observância de critérios isonômicos na organização da fila de espera pela Administração, o princípio da impessoalidade, garantidor da isonomia alvejada nas respostas institucionais às demandas trazidas pela população, não pode servir de justificativa para relativizarem-se peculiaridades individuais no importe de sofrimento desproporcionalmente majorado ou de normalização da precariedade/morosidade na prestação dos serviços públicos.

*Por essas razões, defiro parcialmente a concessão de efeito suspensivo ativo, para fins de deferir a tutela provisória de urgência, determinando-se que os réus, realizem a consulta em Ambulatório 1a vez - **Oncologia**, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se."*

A decisão liminar que atribui o efeito suspensivo ativo ao recurso observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais devendo, dessa maneira, ser ratificada.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao recurso. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado.

1. A parte autora, assistida ou não por advogado, fique desde logo ciente de que não receberá necessariamente comunicações pelo Correio a respeito de todos os atos do Juiz, mesmo quando houver prazo de seu interesse a ser observado. Somente de decisões recorríveis nos termos das Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001 (indeferimento de liminar ou sentença) pode esperar ser intimada por telegrama ou outro meio semelhante. Deve, portanto, inteirar-se periodicamente do estado do processo, inclusive para tomar conhecimento de pagamentos que tenham sido determinados em seu favor. Os meios possíveis para manter-se atualizado sobre todas as ocorrências são a INTERNET, onde o processo pode ser visto em sua integralidade, bem como o comparecimento pessoal ao Juizado. Não serão fornecidas informações por meio de telefone a jurisdicionados ou advogados.

